

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Aprovação	Revisão	Versão	Rotina	Páginas
09/05/2025	09/05/2027	nº 01	SES.DAS nº 50	30
Nome do Procedimento: Como Verificar os Sinais Vitais e Realizar Exame Físico em Criança e Adolescente				
Gerência(s) Responsável(eis) pelo(s) Serviço(s) Executante(s): Gerência da Atenção Primária Distrito Centro, Gerência da Atenção Primária Distrito Norte, Gerência da Atenção Primária Distrito Sul, Gerência de Serviços Especiais e Gerência de Urgência e Emergência e Articulação Hospitalar				
Serviço(s) Responsável(eis) Pela Execução do POP: Atenção Primária à Saúde (APS), Atenção Secundária Especializada, Pronto Atendimento (PA), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)				
Cargo(s) Responsável(eis) Pela Execução das Tarefas: Equipe de enfermagem, médico, nutricionista, fisioterapeuta e profissional de educação física				
Objetivo(s): Orientar as equipes de saúde sobre a aferição dos sinais vitais e sobre a realização do exame físico na criança e adolescente, com a finalidade de reconhecer achados normais esperados para a idade, bem como as anormalidades, servindo de suporte no planejamento do cuidado à criança				
Recursos necessários: → Computador; → Acesso à internet; → Acesso ao Prontuário Eletrônico no Sistema Integrado de Gestão - SIG-SaudeTech (Olostech); → Otoscópio; → Oftalmoscópio; → Estetoscópio; → Termômetro; → Régua Antropométrica Infantil Portátil (Infantômetro); → Fita métrica; → Balança pediátrica; → Balança digital antropométrica; → Esfigmomanômetro infantil; → Espátula; → Lanterna; → Relógio.				

SUMÁRIO

1. DEFINIÇÃO.....	3
2. AFERIÇÃO DOS SINAIS VITAIS.....	3
Quadro 01. Aferição da Temperatura Corporal.....	3
Quadro 02. Aferição da Frequência Cardíaca (FC).....	4
Quadro 03. Aferição da Frequência Respiratória (FR).....	5
Quadro 04. Aferição da Pressão Arterial (PA).....	5

3. EXAME FÍSICO.....	6
3.1. Antropometria.....	6
Quadro 05. Antropometria/Peso.....	7
Quadro 06. Antropometria/Estatura.....	8
Quadro 07. Pontos de corte de IMC-para-idade para crianças menores de 05 (cinco) anos.....	9
Quadro 08. Pontos de corte de IMC-para-idade para crianças entre 05 (cinco) e 10 (dez) anos.....	9
Quadro 09. Antropometria/Perímetro Cefálico.....	10
3.2. Exame Físico Geral.....	10
3.3. Exame Físico Das Crianças De 0 A 18 anos, 11 meses e 29 dias.....	11
Quadro 10. Exame Físico (Olhos).....	11
Quadro 11. Exame Físico (Nariz).....	12
Quadro 12. Exame Físico (Audição).....	12
Quadro 13. Exame Físico (Boca).....	12
Quadro 14. Exame Físico (Tórax).....	13
Quadro 15. Exame Físico (Abdome).....	14
Quadro 16. Exame Físico (Genitália).....	15
Quadro 17. Exame Físico (Ânus).....	16
Quadro 18. Exame Físico (Coluna Vertebral).....	16
Quadro 19. Exame Físico (Desenvolvimento Neuropsicomotor).....	16
4. ESPECIFICIDADE DO EXAME FÍSICO DE 0 A 24 MESES.....	17
4.1. Avaliação Céfalo-Caudal.....	17
Quadro 20. Exame Físico 0 a 24 meses (Estado Geral).....	17
Quadro 21. Exame Físico 0 a 24 meses (Pele).....	17
Quadro 22. Exame Físico 0 a 24 meses (Desenvolvimento Social e Psicoafetivo).....	18
Quadro 23. Exame Físico 0 a 24 meses (Crânio).....	18
Quadro 24. Exame Físico 0 a 24 meses (Face).....	19
Quadro 25. Exame Físico 0 a 24 meses (Olhos).....	19
Quadro 26. Exame Físico 0 a 24 meses (Orelhas/Ouvidos).....	20
Quadro 27. Exame Físico 0 a 24 meses (PESCOÇO).....	20
Quadro 28. Exame Físico 0 a 24 meses (Tórax).....	20
Quadro 29. Exame Físico 0 a 24 meses (Pulsos).....	21
Quadro 30. Exame Físico 0 a 24 meses (Umbigo).....	21
Quadro 31. Exame Físico 0 a 24 meses (Sistema Osteoarticular).....	21
4.2. Avaliação dos Marcos de Desenvolvimento.....	22
4.2.1. Reflexos primitivos.....	22
Quadro 32. Reflexos Primitivos.....	23
REFERÊNCIAS.....	25
ANEXOS.....	27
Anexo 01. Estadiamento de Tanner - Masculino.....	27
Anexo 02. Estadiamento de Tanner - Feminino.....	29

1. DEFINIÇÃO

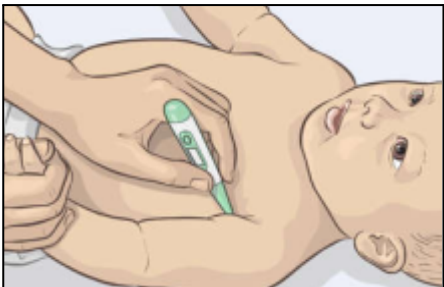
A aferição dos sinais vitais e o exame físico fazem parte da consulta de puericultura, fornecem parâmetros essenciais que indicam o funcionamento adequado dos sistemas vitais e permitem uma avaliação clínica que complementa a anamnese, com objetivo de avaliar e identificar alterações e/ou doenças.

2. AFERIÇÃO DOS SINAIS VITAIS

O monitoramento de sinais vitais é uma das principais ferramentas para avaliar o estado clínico. Cada parâmetro fornece informações valiosas sobre as funções: cardiovascular, respiratória, neurológica e metabólica. **A aferição dos sinais vitais pode ser realizada pela equipe de enfermagem, médico, nutricionista, fisioterapeuta e profissional de educação física, devidamente capacitados.**

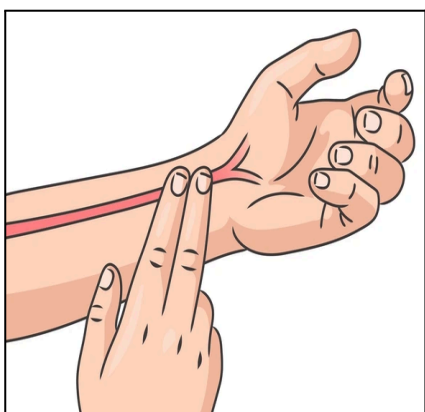
Os sinais vitais a serem monitorados nas consultas de puericultura incluem: Temperatura Corporal, Frequência Cardíaca (FC), Frequência Respiratória (FR), Pressão Arterial (PA).

Quadro 01. Aferição da Temperatura Corporal

TEMPERATURA														
 Aferição de temperatura na região axilar	Aferir a temperatura com termômetro digital na região axilar ou termômetro com sensor infravermelho na região temporal, conforme orientação do fabricante.													
	<table> <tr> <th colspan="2">Classificação da temperatura</th></tr> <tr> <td>Hipotermia</td><td>abaixo de 35°C</td></tr> <tr> <td>Afebril</td><td>36 a 37,2°C</td></tr> <tr> <td>Febril</td><td>37,3 a 37,7°C</td></tr> <tr> <td>Febre/Hipertermia</td><td>37,8 a 38,9°C</td></tr> <tr> <td>Pirexia</td><td>39 a 40°C</td></tr> <tr> <td>Hiperpirexia</td><td>Acima de 40°C</td></tr> </table>	Classificação da temperatura		Hipotermia	abaixo de 35°C	Afebril	36 a 37,2°C	Febril	37,3 a 37,7°C	Febre/Hipertermia	37,8 a 38,9°C	Pirexia	39 a 40°C	Hiperpirexia
Classificação da temperatura														
Hipotermia	abaixo de 35°C													
Afebril	36 a 37,2°C													
Febril	37,3 a 37,7°C													
Febre/Hipertermia	37,8 a 38,9°C													
Pirexia	39 a 40°C													
Hiperpirexia	Acima de 40°C													

Quadro 02. Aferição da Frequência Cardíaca (FC)**FREQUÊNCIA CARDÍACA (FC)**

Pulso apical



Pulso artéria radial

Para verificar a FC em crianças menores de 02 (dois) anos, recomenda-se dar preferência ao **pulso apical**. A frequência apical é verificada colocando-se o estetoscópio próximo ao mamilo esquerdo e auscultando por 01 (um) minuto. Importante lembrar que o aparelho frio na pele do bebê estimula o choro podendo ocasionar alteração no resultado;

Em crianças maiores de 02 (dois) anos, a verificação do pulso pode ser feita diretamente por palpação em uma das artérias: braquial, radial, femoral, carótida, temporal, pediosa e poplítea.

Valores de referência FC
(batimentos por minuto - BPM)

Idade	Varição	Média Normal
RN	70 a 170 bpm	120 bpm
11 meses	80 a 160 bpm	120 bpm
2 anos	80 a 130 bpm	110 bpm
4 anos	80 a 120 bpm	100 bpm
6 anos	75 a 115 bpm	100 bpm
8 a 10 anos	70 a 100 bpm	90 bpm
>10 anos	60 a 100 bpm	75 bpm

Quadro 03. Aferição da Frequência Respiratória (FR)**FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (FR)**

Tiragem intercostal e subcostal

Para verificar a FR, a criança deve estar tranquila e, se possível, a roupa deve ser removida da metade superior do corpo, de modo a expor a região tóraco-diafragmática.

Deve-se contar a frequência respiratória durante 01 (um) minuto, observando os movimentos inspiratórios torácicos e abdominais.

Valores de referência FR (movimentos respiratórios por minuto - MRM)	
Idade	FR normal
0 a 30 dias	de 30 a 60 mrm
de 30 dias a > de 1 ano	de 30 a 53 mrm
1 a 2 anos	de 22 a 37 mrm
3 a 5 anos	de 20 a 30 mrm
6 a 12 anos	de 18 a 30 mrm
13 a 18 anos	de 12 a 20 mrm

Quadro 04. Aferição da Pressão Arterial (PA)**PRESSÃO ARTERIAL (PA)**

A aferição da PA deve ser realizada anualmente a **partir dos 03 (três) anos** de idade em **todas as consultas de puericultura**.



Para crianças **menores de 03 (três) anos**, a aferição da PA está indicada em caso de história neonatal de prematuridade (<32 semanas), baixo peso ao nascer, cateterismo umbilical, complicações que requerem unidade de tratamento intensivo (UTI), doenças cardíacas (cardiopatias congênitas corrigidas ou não), transplantes (medula óssea ou órgãos sólidos), neoplasias, uso de drogas hipertensoras (corticóides), doenças associadas como anemia falciforme, neurofibromatose, esclerose tuberosa, aumento da pressão intracraniana, doenças renais, malformações nefrourológicas, infecções do trato urinário, hematúria e proteinúria.

Em caso de dúvidas no procedimento da aferição da PA em crianças e adolescentes e interpretação dos valores, consultar o **POP SES.DAS nº 12 - Como Aferir e Interpretar os Valores da Pressão Arterial em Criança e Adolescente**, que estará disponível no Processo SEI nº 25.0.002158-5.

3. EXAME FÍSICO

O exame físico é dividido em: Antropometria, Exame físico geral (ectoscopia) e Exame físico segmentar.

Importante:

- Para realização do exame físico em **crianças nascidas prematuramente**, deve-se corrigir a idade para 40 semanas (nascidos com menos de 28 semanas de idade gestacional a recomendação é de utilizar a idade corrigida até os 03 (três) anos de vida, e para nascidos a partir de 28 semanas de idade gestacional a recomendação é utilizar a idade corrigida até os 02 (dois) anos. Exemplo:

Orientações para a correção da idade em Prematuros:

- Para realizar a correção da idade no caso de prematuros, utiliza-se o cálculo = a idade cronológica atual (i.c.a.) menos a diferença entre 40 semanas e a idade gestacional no parto (i.g.p.).
Ou seja: *idade corrigida* = $i.c.a - (40 - i.g.p.)$;
- Exemplo: se o lactente estiver atualmente com 4 meses (16 semanas) de idade (i.c.a.), e o parto ocorreu com 32 semanas de gestação (i.g.p.), a idade corrigida corresponde à 2 meses (8 semanas) de idade ($idade\ corrigida = 16 - (40 - 32) \rightarrow 16 - 8 = 8\text{ semanas}/2\text{ meses}$);
- Lembrando que, a idade corrigida é usada para prematuros que nasceram antes das 37 semanas de gestação.

- Importante oferecer brinquedos, livros ou outra forma de distração para tranquilizar a criança durante o exame físico;
 - Recomenda-se que, procedimentos como o exame da orofaringe e otoscopia, sejam realizados apenas ao final do exame físico pois são mais invasivos e irritam a criança, podendo interferir no restante do exame.

3.1. Antropometria

O método antropométrico permite a avaliação do peso, da estatura e de outras medidas do corpo humano, e **pode ser realizado pela equipe de enfermagem, médico, nutricionista, fisioterapeuta e profissional de educação física, devidamente capacitados**.

A antropometria representa um importante recurso para a avaliação do estado nutricional e ainda oferece dados para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento de crianças e adolescentes.

Nesta etapa do exame físico, deve-se realizar as seguintes medidas:

→ Peso;

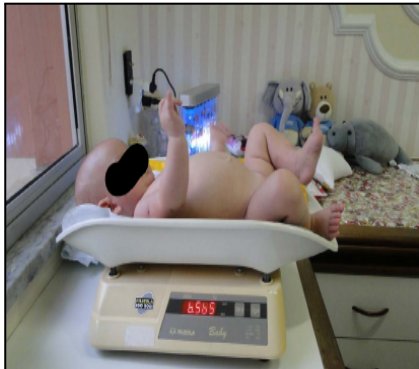
→ Estatura: Comprimento/Altura (adota-se o termo “comprimento” para a estatura de crianças menores de 02 (dois) anos e o termo “altura” para a estatura de crianças maiores de 02 (dois) anos);

→ Índice de Massa Corpórea (IMC);

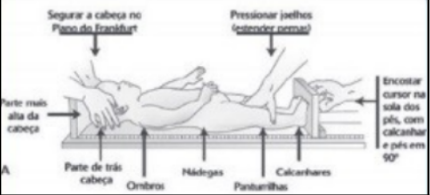
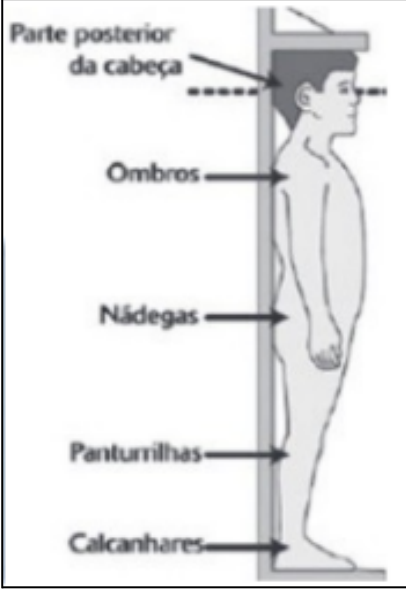
→ Perímetro Cefálico (PC).

Importante: Peso, Estatura, IMC e o PC devem ser avaliados e registrados nos gráficos da Caderneta da Criança e em prontuário eletrônico na pré-consulta.

Quadro 05. Antropometria/Peso

ANTROPOMETRIA																			
Peso	Ações Específicas																		
  Pesagem da criança até 23 meses ou 16Kg	Utilizar balança pediátrica ou “tipo bebê” (como na imagem ao lado) apropriada para crianças até 23 meses ou 16Kg. Deve-se pesar a criança sem a fralda até 01 (um) ano de idade e com menos vestimentas possível até os 02 (dois) anos de idade. Para crianças a partir de 24 meses ou com peso acima de 16 kg, recomenda-se o uso da balança “tipo adulto”. Deve-se pesar a criança descalça e com o mínimo de roupa possível.																		
	Considera-se “dentro dos padrões de normalidade” uma perda de peso de até 10%, devendo nesta situação realizar o acompanhamento com controle de peso até a normalização.																		
	<table><tr><th colspan="3">Média de ganho de peso ponderal/mês no primeiro ano de vida</th></tr><tr><th>1º ano</th><th>Gramas/Mês</th><th>Gramas/Dia</th></tr><tr><td>1º trimestre</td><td>700 g</td><td>25-30g</td></tr><tr><td>2º trimestre</td><td>500-600g</td><td>20g</td></tr><tr><td>3º trimestre</td><td>400-500g</td><td>15g</td></tr><tr><td>4º trimestre</td><td>350-450g</td><td>10g</td></tr></table>		Média de ganho de peso ponderal/mês no primeiro ano de vida			1º ano	Gramas/Mês	Gramas/Dia	1º trimestre	700 g	25-30g	2º trimestre	500-600g	20g	3º trimestre	400-500g	15g	4º trimestre	350-450g
Média de ganho de peso ponderal/mês no primeiro ano de vida																			
1º ano	Gramas/Mês	Gramas/Dia																	
1º trimestre	700 g	25-30g																	
2º trimestre	500-600g	20g																	
3º trimestre	400-500g	15g																	
4º trimestre	350-450g	10g																	

Quadro 06. Antropometria/Estatura

ANTROPOMETRIA																	
Estatura	Ações Específicas																
 Medida do comprimento da criança até 02 (dois) anos de idade  Medida do comprimento da criança maior de 02 (dois) anos de idade	Comprimento/Altura: Para crianças com até 02 (dois) anos de idade, deve-se utilizar a régua antropométrica graduada com uma extremidade fixa e uma móvel, como na figura ao lado. Para crianças maiores de 02 (dois) anos de idade, deve-se utilizar a balança antropométrica ou régua vertical, na posição ereta, com os calcâneos próximos e a postura vertical alinhada. Observação: Para medir a criança, a mesma deve estar sem nenhum calçado. A estimativa de crescimento está descrita a seguir: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Idade</th><th>Estimativa de Crescimento</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 a 12 meses</td><td>25 cm/ano (15cm primeiro semestre e 10 cm no segundo)</td></tr> <tr> <td>1 a 2 anos</td><td>10 à 13 cm/ano</td></tr> <tr> <td>2 a 4 anos</td><td>7 cm/ano</td></tr> <tr> <td>4 a 6 anos</td><td>6 cm/ano</td></tr> <tr> <td>6 anos até início da puberdade</td><td>5 cm/ano</td></tr> <tr> <td>Estirão Puberal meninas</td><td>8 à 10 cm/ano</td></tr> <tr> <td>Estirão Puberal meninos</td><td>10 à 12 cm/ano</td></tr> </tbody> </table>	Idade	Estimativa de Crescimento	0 a 12 meses	25 cm/ano (15cm primeiro semestre e 10 cm no segundo)	1 a 2 anos	10 à 13 cm/ano	2 a 4 anos	7 cm/ano	4 a 6 anos	6 cm/ano	6 anos até início da puberdade	5 cm/ano	Estirão Puberal meninas	8 à 10 cm/ano	Estirão Puberal meninos	10 à 12 cm/ano
Idade	Estimativa de Crescimento																
0 a 12 meses	25 cm/ano (15cm primeiro semestre e 10 cm no segundo)																
1 a 2 anos	10 à 13 cm/ano																
2 a 4 anos	7 cm/ano																
4 a 6 anos	6 cm/ano																
6 anos até início da puberdade	5 cm/ano																
Estirão Puberal meninas	8 à 10 cm/ano																
Estirão Puberal meninos	10 à 12 cm/ano																

Deve-se realizar o cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC) para verificar o estado nutricional da criança, seguindo a fórmula abaixo:

$$\text{IMC} = \text{PESO (Kg)} / \text{ALTURA (m)}^2$$

Com base no peso, altura e IMC, classifica-se o estado nutricional da criança, utilizando os gráficos que constam na caderneta da criança, podendo utilizar: comprimento/idade (C/I) ou estatura/idade (E/I), peso/idade (P/I) e IMC/idade (IMC/I).

Quadro 07. Pontos de corte de IMC-para-idade para crianças menores de 05 (cinco) anos

VALORES CRÍTICOS		DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
< Percentil 0,1	< Escore-z -3	Magreza acentuada
$\geq$ Percentil 0,1 e < Percentil 3	$\geq$ Escore-z -3 e $\leq$ Escore-z -2	Magreza
> Percentil 3 e $\leq$ Percentil 85	$\geq$ Escore-z -2 e $\leq$ Escore-z +1	Eutrofia
> Percentil 85 e $\leq$ Percentil 97	> Escore-z +1 e $\leq$ Escore-z +2	Risco de sobrepeso
> Percentil 97 e $\leq$ Percentil 99,9	> Escore-z +2 e $\leq$ Escore-z +3	Sobrepeso
> Percentil 99,9	> Escore-z +3	Obesidade

Fonte: Brasil, 2011.

Quadro 08. Pontos de corte de IMC-para-idade para crianças entre 05 (cinco) e 10 (dez) anos

VALORES CRÍTICOS		DIAGNÓSTICO NUTRICIONAL
< Percentil 0,1	< Escore-z -3	Magreza acentuada
$\geq$ Percentil 0,1 e < Percentil 3	$\geq$ Escore-z -3 e < Escore-z -2	Magreza
$\geq$ Percentil 3 e $\leq$ Percentil 85	> Escore-z -2 e $\leq$ Escore-z +1	Eutrofia
> Percentil 85 e $\leq$ Percentil 97	> Escore-z +1 e $\leq$ Escore-z +2	Sobrepeso
> Percentil 97 e $\leq$ Percentil 99,9	> Escore-z +2 e $\leq$ Escore-z +3	Obesidade
> Percentil 99,9	> Escore-z +3	Obesidade grave

Fonte: Brasil, 2011.

Quadro 09. Antropometria/Perímetro Cefálico**ANTROPOMETRIA****Perímetro Cefálico - PC (Ações Específicas)**

PC: Deve-se medir e acompanhar a evolução em toda consulta **até 02 anos 11 meses e 29 dias** (em prematuros, conforme a idade corrigida);

Para mensuração do perímetro cefálico, deve-se utilizar fita métrica, passando-a ao redor do crânio pelas partes mais salientes do osso frontal e occipital, conforme disposto na imagem abaixo:



Ganho médio esperado de PC até o 2º ano de vida:

Idade	Comprimento/mês
1º e 2º mês de vida	2 cm mês
3º e 4º mês de vida	1,5 cm mês
5º ao 12º mês de vida	0,5 cm mês
No 2º ano de vida	0,3 cm mês

Alterações no PC de até 02 (dois) desvios padrão (≤ 2 ou ≥ 2 escores “z”) podem estar relacionadas à síndromes genéticas e/ou doenças neurológicas. Ao identificar essas alterações, deve-se encaminhar a criança para avaliação com a especialidade indicada (genética e/ou neurológica).

Fonte: Adaptado Saúde da Criança Caderno 23 /MS-2011.

3.2. Exame Físico Geral

É a observação do estado geral da criança/adolescente que envolve a análise do aspecto da fisionomia (alegre, apática ou triste); interação com o meio (calma, agitada, assustada, irritada); resposta aos estímulos ambientais e interação com as pessoas (comunicativa, recíproca, interessada, desinteressada, brincando, retraída); postura (ereta, relaxada, encolhida, de proteção de uma área do corpo dolorida ou incômoda); se exibe traços característicos ou deformidades físicas; estado nutricional e de hidratação; aspectos de higiene e vestuário, **pode ser realizado pelo enfermeiro e médico.**

Importante:

Para a primeira avaliação do Recém-Nascido (RN) realizada na primeira semana de vida do RN, recomenda-se seguir as orientações descritas no POP nº 41 - Primeira Avaliação do Recém-Nascido (RN) e Puérpera até o quinto (5º) dia de vida da Criança (Primeira Semana de Saúde Integral), disponível no Processo SEI nº 21.0.211798-1.



Etapas do exame físico:

→ **Inspeção:** avaliar o aspecto visual do corpo da criança quanto à forma, cor, simetria, odor e presença de anormalidades;

→ **Palpação:** tem a finalidade de “sentir” os órgãos, glândulas, vasos, pele, músculos e ossos, a fim de detectar a presença ou ausência de massas; pulsação, aumento de um órgão, aumento ou diminuição da sensibilidade, edema, espasmo ou rigidez muscular, elasticidade, vibração de sons vocais, crepitação, umidade e diferenças de texturas;

→ **Percussão:** golpear com cuidado a superfície do corpo de forma rápida, porém aguda para produzir sons que permitam ao examinador determinar a posição, tamanho, densidade de uma estrutura adjacente;

→ **Auscultação:** permite ouvir os sons corporais, procurando identificar anormalidades.

Importante: Para adolescentes com idade entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, deve-se acrescentar ao exame físico a Escala de Tanner (Anexos 01. e 02.) para mensurar a maturidade sexual.

3.3. Exame Físico Das Crianças De 0 A 18 anos, 11 meses e 29 dias

Quadro 10. Exame Físico (Olhos)

OLHOS	
	Avaliar: simetria, conjuntiva, presença de estrabismo, secreção ocular e edema. A partir dos 03 (três) anos de idade, indica-se a triagem da acuidade visual, com auxílio de tabelas de letras ou figuras quando a criança vier para consultas de revisão. Em caso de alterações, encaminhar ao oftalmologista através do Sistema SIG-SaudeTech (Olostech).

Estrabismo

Quadro 11. Exame Físico (Nariz)

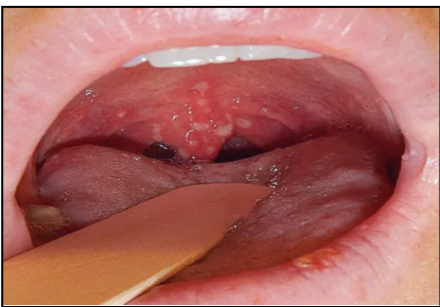
NARIZ	
	Avaliar obstrução nasal;
	Avaliar o formato, as secreções e a presença de lesões;
	Nos casos em que a criança apresente coriza de repetição, além da investigação para doenças respiratórias, recomenda-se também verificar a possibilidade de sífilis congênita.

Lesão nasal

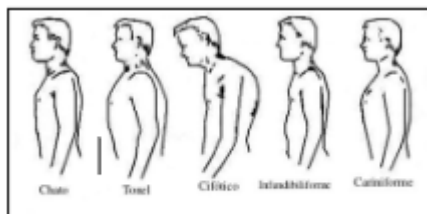
Quadro 12. Exame Físico (Audição)

AVALIAÇÃO DA AUDIÇÃO	
Para avaliar as alterações auditivas, o profissional médico ou enfermeiro deve realizar a “Avaliação dos Marcos de Desenvolvimento” que consta na Caderneta de Saúde da Criança; Lembrando que a Perda Auditiva pode provocar o atraso na fala sendo de suma importância a avaliação, identificação precoce e conduta de reabilitação.	
	Otoscopia: É o exame visual direto do canal auditivo externo e da membrana timpânica. Deve-se checar a presença de: • Aparência da Membrana Timpânica (abaulada ou retraída); • Cerume, corpos estranhos (Canal Auditivo Externo); • Hiperemia; • Integridade; • Processos inflamatórios, sangue, secreção purulenta.

Quadro 13. Exame Físico (Boca)

BOCA	
	Observar a integridade e coloração da mucosa oral;
	Realizar inspeção dos dentes, gengivas, face interna das bochechas, língua e palatos;
	Verificar o tamanho e aspecto das amígdalas;
	Avaliar hiperemia, petéquias e lesões na mucosa;
	Avaliar aspecto do palato (normal, em ogiva) e sua integridade (presença de fenda palatina).

Amigdalite

Quadro 14. Exame Físico (Tórax)**TÓRAX (SISTEMA RESPIRATÓRIO E CIRCULATÓRIO)****Inspeção do tórax:**

Formato do tórax

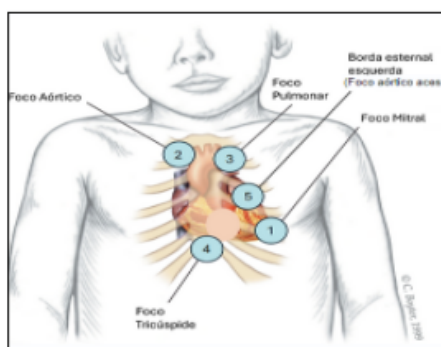
- Avaliar simetria do tórax, abaulamentos ou retrações;
- Estágio de desenvolvimento mamário (nas adolescentes púberes), conforme Escala Puberal de Tanner (Anexo 02.);
- Avaliar presença de ginecomastia (em meninos);
- Observar alterações cutâneas.

Sistema Respiratório:**Inspeção:**

- Verificar frequência respiratória;
- Observar presença de tiragem intercostal;
- Avaliar o ritmo da respiração;
- Observar a expansibilidade torácica e uso de músculos acessórios;
- Observar quanto à ocorrência de tosse (seca ou produtiva);
- Se tosse produtiva avaliar a característica da secreção (cor e consistência);
- Observar presença de cianose perioral e/ou de leito ungueal.

Ausculta:

- Avaliar a intensidade e distribuição do murmúrio vesicular e a presença de ruídos adventícios (roncos, sibilos, estertores finos e grossos, sopro tubário, atrito pleural);
- Avaliar alterações da voz à ausculta (broncofonia, pectorilóquia, egofonia).

Sistema Circulatório: Focos de ausculta cardíaca

Focos de ausculta cardíaca

Verificar a frequência e o ritmo cardíaco, as características das bulhas e a existência de sopros. Os sopros devem ser caracterizados quanto ao foco onde é mais audível, intensidade, o momento do ciclo em que ocorre (sistólico, diastólico, contínuo), o timbre, irradiação, entre outras características. Em caso de suspeita de alteração, deve-se encaminhar a criança para avaliação com Pediatra de referência.

Quadro 15. Exame Físico (Abdome)**ABDOME**

Observar a forma do abdome: plano, emagrecido, globoso, distendido;

Realizar palpação geral, superficial e profunda, observando presença de dor abdominal e sua localização, defesa ou rigidez da parede;

Percussão: delimitar o tamanho do fígado, presença de gases ou massas;

Realizar ausculta: verificar ruídos hidroaéreos em cada quadrante do abdômen;



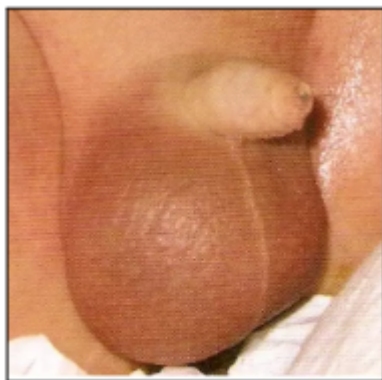
Observar a presença de abdome globoso, distendido, com ondas peristálticas visíveis, podem sugerir obstrução. Abdome escavado é sugestivo de hérnia diafragmática;

Avaliar presença de hérnias de parede abdominal;

Na região umbilical, verificar a presença de granuloma, hiperemia, edema e secreção.

Quadro 16. Exame Físico (Genitália)**GENITÁLIA**

Genitália ambígua



Hidrocele

Leucorréia fisiológica
neonatal/hiperemia

Realizar inspeção geral da genitália, observar se a genitália é tipicamente feminina ou masculina;

Nos casos de "genitália ambígua", recomenda-se o encaminhamento para pediatra.

Genitália masculina:

- Realizar palpação de bolsa escrotal, verificar a presença dos testículos na bolsa escrotal, bem como sua forma, consistência e simetria em relação ao tamanho. Se, aos 06 (seis) meses de idade, os testículos não forem palpados na bolsa escrotal, a criança deve ser encaminhada para avaliação do pediatra;
- Observar aumento de volume escrotal (que pode ser indicativo de hidrocele ou hérnia inguinal);
- Realizar tração gentil do prepúcio para avaliação de meato uretral (avaliar anormalidades de posicionamento como hipospádia e epispádia);
- A presença de fimose é fisiológica e esperada nessa faixa etária, devendo ser acompanhada na UBSF até os 05 (cinco) anos. Havendo permanência de fimose após os 05 (cinco) anos de idade, recomenda-se o encaminhamento para avaliação com pediatra.

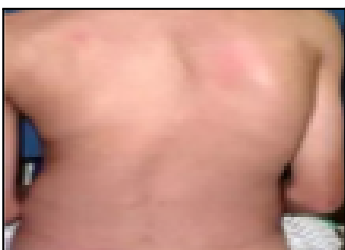
Genitália feminina:

- Realizar ectoscopia, avaliando pequenos lábios, grandes lábios, meato uretral, intróito vaginal. Avaliar presença de sinéquia de pequenos lábios;
- Observar presença de secreção esbranquiçada/avermelhada na fralda, isso pode ocorrer até a segunda semana de vida devido à passagem de hormônios maternos, que se resolvem espontaneamente (leucorréia fisiológica, fig. 18);
- Observar presença de secreções, lesões, hiperemia, dermatites, entre outros;
- Orientar a higiene correta.

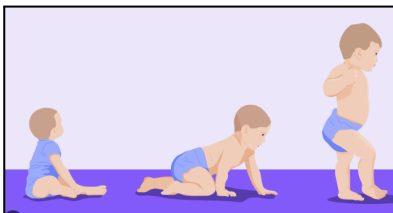
Quadro 17. Exame Físico (Ânus)

ÂNUS	
 HPV em região anal	Verificar posição e perviedade do orifício anal; Observar: presença de assaduras, presença de fissuras ou sinais que podem ser indicativos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), como lesões granulomatosas, alargamento e hematoma de ânus.

Quadro 18. Exame Físico (Coluna Vertebral)

COLUNA VERTEBRAL	
 Cifoesciose	Examinar a coluna vertebral, especialmente a área sacrolombar, percorrendo com os dedos a linha média em busca de espinha bífida, mielomeningocele e outras malformações (sinus sacral acima do promontório, pilosidades locais, hemangiomas capilares ou acúmulo anormal de gordura que sugerem espinha bífida oculta).

Quadro 19. Exame Físico (Desenvolvimento Neuropsicomotor)

DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR	
 Desenvolvimento infantil	Avaliar os marcos do desenvolvimento de acordo com o “Instrumento de Vigilância do Desenvolvimento da Criança” que consta na Caderneta da Saúde da Criança; Avaliar o desenvolvimento social e motor; Avaliar o desenvolvimento da linguagem.

Importante:

- Se houver **alterações no exame físico e dúvida na conduta e/ou suspeita de atraso no desenvolvimento**, encaminhar para avaliação com pediatra da APS;
- **Havendo suspeita de violência sexual**, seguir o fluxo do Protocolo Aconchegar disponível no Processo SEI nº 23.0.213387-5 e na página da Prefeitura Municipal de Joinville:
<https://www.joinville.sc.gov.br/publicacoes/protocolo-de-atendimento-as-pessoas-em-situacao-de-violencia-sexual>.

4. ESPECIFICIDADE DO EXAME FÍSICO DE 0 A 24 MESES

4.1. Avaliação Céfalo-Caudal

Quadro 20. Exame Físico 0 a 24 meses (Estado Geral)

TÓPICOS DO EXAME FÍSICO	
Estado Geral	Ações Específicas
 Postura comum do RN	Avaliar a postura normal do RN: as extremidades fletidas, as mãos fechadas e o rosto, geralmente, dirigido a um dos lados. Em caso de assimetria, recomenda-se investigar possibilidade de fratura de clavícula ou membros ou paralisia braquial. Observar se a criança apresenta torcicolo congênito, sonolenta, chorosa, etc.

Quadro 21. Exame Físico 0 a 24 meses (Pele)

TÓPICOS DO EXAME FÍSICO	
Pele (Ações Específicas)	
A pele da criança deve estar corada, lisa, flexível, elástica, isenta de lesões e inflamações.	
 Cianose Central	Observar: presença de edema, pigmentação, cianose, palidez, icterícia, mancha mongólica, eritema tóxico, máculas vasculares, cutis marmorata, hemangiomas e petéquias; Avaliar presença de cianose de extremidades que se apresentam frias ao toque (acrocianose). Já a cianose central é caracterizada pela pigmentação azulada da pele, lábios e língua e/ou leito ungueal, associa-se geralmente a doenças cardiorrespiratórias;
Icterícia: Seguir as orientações descritas no Fluxograma - Avaliação de Icterícia Neonatal na Atenção Primária na primeira semana de vida (RN entre 2º e 5º dia de vida) disponível no Processo SEI nº 21.0.211798-1; Verificar a presença de assaduras, palmo-plantares.	

TÓPICOS DO EXAME FÍSICO

Pele (Ações Específicas)

Vasos sanguíneos: observar a presença de hemangiomas, circulação colateral (presença de veias dilatadas), púrpura (manchas vermelhas ou roxas na pele, que não desaparecem quando pressionadas), petéquias e equimoses.

Quadro 22. Exame Físico 0 a 24 meses (Desenvolvimento Social e Psicoafetivo)

TÓPICOS DO EXAME FÍSICO

Desenvolvimento Social e Psicoafetivo



Relacionamento afetivo mãe e filho

Ações Específicas

Observar o padrão de relacionamento da mãe/cuidador e dos familiares com o bebê: como respondem às suas manifestações, como interagem com o bebê e se lhe proporcionam situações variadas de estímulo;

Questionar sobre exposição a telas e orientar os riscos e prejuízos da exposição precoce.

Quadro 23. Exame Físico 0 a 24 meses (Crânio)

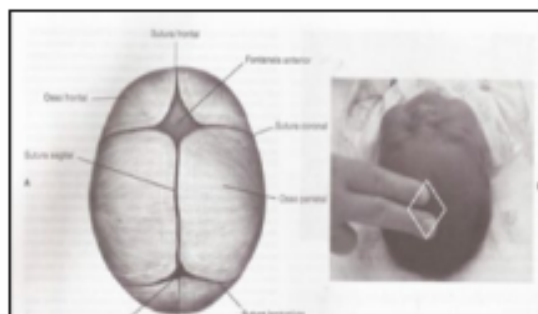
TÓPICOS DO EXAME FÍSICO

Crânio (Ações Específicas)

Avaliar formato, dimensão, deformidades do crânio;

Avaliar as fontanelas:

- Fontanela anterior: fecha entre o 9º e o 18º mês;
- Fontanela posterior: é triangular, fecha até o 2º mês;
- As fontanelas normalmente devem estar firmes e ligeiramente côncavas, caso apresente abaulamento, deve-se investigar a possibilidade de aumento da pressão intracraniana, podendo sugerir: meningite, hidrocefalia, edema cerebral ou hemorragia intracraniana;
- Quando as fontanelas se apresentam deprimidas, associa-se à desidratação.



Fontanelas

TÓPICOS DO EXAME FÍSICO

Crânio (Ações Específicas)

Verificar a presença de lesões cutâneas (fúngicas ou bacterianas) no couro cabeludo.

Observar o cabelo, a distribuição e as características dos cabelos (alopecia, desidratado), podem sugerir problemas nutricionais, metabólicos, endocrinológicos ou dermatológicos.



Alopécia

Quadro 24. Exame Físico 0 a 24 meses (Face)

TÓPICOS DO EXAME FÍSICO

Face

Ações Específicas



Lesões em face

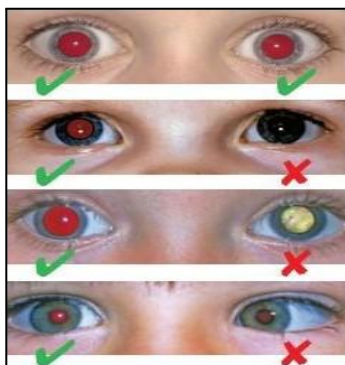
Avaliar simetria, malformação, aparência sindrômica, cor e presença de lesões.

Quadro 25. Exame Físico 0 a 24 meses (Olhos)

TÓPICOS DO EXAME FÍSICO

Olhos

Ações Específicas



Teste do reflexo vermelho normal e alterado

Avaliar simetria, conjuntiva, presença de estrabismo, secreção ocular e edema;

Teste do Reflexo Vermelho: O teste deve ser realizado ainda no hospital, na **primeira consulta do RN e na APS, e repetido aos 04, 06, 12 e 24 meses pelo médico ou enfermeiro capacitado.**

Quadro 26. Exame Físico 0 a 24 meses (Orelhas/Ouvidos)

TÓPICOS DO EXAME FÍSICO	
Orelhas/Ouvidos	Ações Específicas
 Formato da orelha	Observar: Simetria, forma, integridade, implantação e tamanho, higiene e presença de secreções na orelha; Avaliar audição: RN responde piscando os olhos à emissão de um ruído próximo ao ouvido (reflexo cócleo-palpebral).

Quadro 27. Exame Físico 0 a 24 meses (Pescoço)

TÓPICOS DO EXAME FÍSICO	
Pescoço	Ações Específicas
 Torticolo congênito	Observar presença de bócio, fístulas e cistos; Avaliar se há indícios de torcicolo congênito, na suspeita encaminhar para avaliação do pediatra; Inspecionar e palpar gânglios cervicais, submandibulares e retroauriculares; Avaliar rigidez da nuca; Observar se há turgência venosa jugular (presente na insuficiência cardíaca congestiva). Neste caso deve-se encaminhar ao cardiologista.

Quadro 28. Exame Físico 0 a 24 meses (Tórax)

TÓPICOS DO EXAME FÍSICO	
Tórax	Ações Específicas
 Edema de mamas	Avaliar formato e simetria do tórax; Apalpar as clavículas para avaliar presença de fraturas; Orientar a família que as mamas da criança podem apresentar edema, ingurgitação ou presença de secreção leitosa nos primeiros dias de vida devido a presença de hormônios maternos na criança e que apresentam involução espontânea.

Quadro 29. Exame Físico 0 a 24 meses (Pulsos)

TÓPICOS DO EXAME FÍSICO	
Pulsos	Ações Específicas
 Verificação de pulso femoral e braquial	Realizar palpação, de forma concomitante bilateralmente, dos pulsos centrais em membros superiores - MMSS (braquiais) e inferiores - MMII (femorais), para avaliar presença e simetria da pulsação; A ausência ou redução de pulsos em MMSS e MMII pode indicar cardiopatias como coarctação de aorta.

Quadro 30. Exame Físico 0 a 24 meses (Umbigo)

TÓPICOS DO EXAME FÍSICO	
Umbigo	Ações Específicas
 Onfalite	Se RN, avaliar umbigo até os 30 dias de vida: • Observar higiene; • Observar sinais de onfalite (vermelhidão na pele ao redor do coto umbilical); • Observar se há presença de secreção purulenta. Neste caso, orientar a higiene correta e encaminhar para avaliação médica.

Quadro 31. Exame Físico 0 a 24 meses (Sistema Osteoarticular)

TÓPICOS DO EXAME FÍSICO	
Sistema Osteoarticular	Ações Específicas
 Manobra de Barlow Manobra de Ortolani Testes de Ortolani e de Barlow	Realizar os testes de Ortolani e de Barlow até os três meses de vida para verificar a presença de displasia do quadril; Examinar os membros superiores e inferiores, para avaliar sua resistência à extensão, a flexão dos membros, a possibilidade de flacidez excessiva e presença de paralisia;

TÓPICOS DO EXAME FÍSICO	
Sistema Osteoarticular	Ações Específicas
 Pé equino/varum (pé torto congênito)	Identificar a presença de pé torto, que pode ser posicional pela postura ou posição do bebê intra-útero ou pé torto congênito (PTC); Membros superiores e inferiores: avaliar edema, alterações da mobilidade, sinais inflamatórios (artrites, miosites); deformidades (genu varo, genu valgo), alterações de marcha (atáxica, claudicante); anomalias congênitas (polidactilias, sindactilias, amelias e focomelias); tamanho dos membros e simetria.

Fonte: Adaptado Saúde da Criança Caderno 23/MS-2011.

Nota: Em caso de necessidade de auxílio no diagnóstico de anomalias congênitas, consulte o “POP SES.DAS nº 07 - Como utilizar o Aplicativo (App) Birth Defects como ferramenta auxiliar para pesquisa e/ou apoio na avaliação da suspeita diagnóstica de Anomalias Congênitas”, disponível no Processo SEI Nº 24.0.244516-0.

4.2. Avaliação dos Marcos de Desenvolvimento

Avaliar o desenvolvimento infantil é uma tarefa complexa que exige uma vigilância contínua nos primeiros anos de vida e conhecimento dos padrões típicos do desenvolvimento infantil, pode ser realizada pelo enfermeiro, médico e fisioterapeuta, devidamente capacitados.

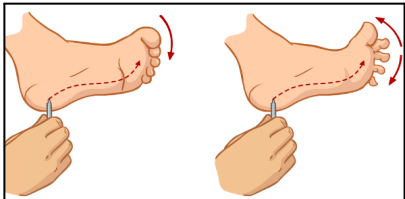
A Caderneta da Criança é o instrumento para o acompanhamento dos Marcos de Desenvolvimento, devendo ser utilizada em todas consultas como referência

4.2.1. Reflexos primitivos

São respostas automáticas e estereotipadas a um determinado estímulo externo. Estão presentes desde o nascimento, porém devem desaparecer ao longo dos primeiros meses, quando surgem os reflexos posturais. A presença dos reflexos primitivos sugere a integridade do sistema nervoso central, entretanto, sua persistência sugere a possibilidade de disfunção neurológica.

Quadro 32. Reflexos Primitivos

TEMPO MÉDIO DE DESAPARECIMENTO DO REFLEXO	REFLEXO	DEFINIÇÃO
Até o 2º Mês de Vida	Reflexo de marcha 	É desencadeada quando o examinador segura a criança pelas axilas na posição vertical, em uma superfície plana e dura, deixando o contato da planta dos pés com a superfície, a criança estenderá os joelhos, que se mantinham semifletidos e fará movimentos semelhantes a caminhar.
Até o 3º Mês de Vida	Reflexo tônico cervical assimétrico 	O examinador deverá colocar a criança em decúbito dorsal, com braços estendidos, o reflexo é desencadeado ao realizar a rotação da cabeça, lateralizando. Deverá observar a extensão de braço e perna, no lado para o qual está voltada a face, enquanto os membros do lado correspondente à região occipital entram em flexão.
	Reflexos de sucção 	Pode ser desencadeado quando o examinador, utilizando luvas, estimula os lábios da criança com o dedo indicador. Observa-se sucção vigorosa. Sua ausência sugere disfunção neurológica e necessita de avaliação do especialista.
Até o 4º Mês de Vida	Reflexo de Busca 	Pode ser desencadeado quando o examinador, utilizando luvas, estimula pontos na face ao redor da boca. Observa-se rotação da cabeça na tentativa de “buscar” o objeto, seguido de sucção reflexa do mesmo.

TEMPO MÉDIO DE DESAPARECIMENTO DO REFLEXO	REFLEXO	DEFINIÇÃO
Até o 5º Mês de Vida	Reflexo de moro 	É desencadeado quando o examinador simula uma queda súbita da cabeça, amparada pela mão do examinador. Observa-se extensão e abdução dos membros superiores seguida por choro.
Até o 6º Mês de Vida	Reflexo de Preensão palmar 	É desencadeado após o examinador colocar o dedo na palma da mão da criança. A criança responde com flexão de todos os dedos, flexão e adução do polegar, simultaneamente.
Até os 15 Meses de Vida	Reflexo da preensão Plantar 	É desencadeado quando o examinador realiza pressão com as mãos na base dos artelhos. Observa-se flexão dos dedos.
Até os 18 Meses de Vida	Preensão Plantar - sinal de babinski 	É desencadeado quando o examinador estimula o pé da criança, por meio de cócegas na planta do pé. Os artelhos se abrem em leque, o pé vira para dentro.

Fonte: Adaptado de Unicamp/Faculdade de Ciências médica.

Nota: Alterações na avaliação com **necessidade de encaminhamentos para especialistas** deverão seguir os protocolos vigentes do Município, e para avaliação com a especialidade pediatria ou ginecologia deve-se seguir orientações da “Nota Técnica de Encaminhamento para Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria na Atenção Primária”, disponível no Processo SEI Nº 23.0.145523-2.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento**. 272 p.: il. – Cadernos de Atenção Básica, nº 33. Brasília - DF: 2012;

BRASIL. Ministério da Saúde. **Linha de Cuidado de Puericultura e Hebicultura**. Disponível em: <https://linhasdecuidado.saude.gov.br/portal/puericultura/unidade-de-atencao-primaria/>. Acesso em: 22/05/2024;

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Orientações para a coleta e análise de dados antropométricos em serviços de saúde: Norma Técnica do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional-SISVAN/2011**. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/orientacoes_coleta_analise_dados_antropometricos.pdf. Acesso em 08/08/2024;

MINAS GERAIS. Município de Juiz de Fora. **Exame Físico em Pediatria**. Disponível em: <https://www.roteirosdepediatria.com/exame-f%C3%ADsico-em-pediatria>. Acesso em 16/05/2024;

PARÁ. Universidade do Estado do Pará - UEPA. **Manual de habilidades profissionais: atenção à saúde da criança maior/Organização de Rosa de Fátima da Silva Vieira Marques et al. – Belém: EDUEPA, 2020**. Disponível em: <https://paginas.uepa.br/eduepa/wp-content/uploads/2020/07/MANUAL-DE-HABILIDADES-PEDIATRIA-1-ED.pdf>. Acesso em 13/09/2024;

PARANÁ. Prefeitura de Londrina. Secretaria Municipal de Saúde. **Linha Guia de Saúde da Criança. 1ª edição**. Londrina - PR: 2023;

SANTA CATARINA. Florianópolis. Universidade Federal de Santa Catarina Centro de Ciências da Educação Núcleo de Desenvolvimento Infantil. **Manual De Normas e Rotinas Procedimentos Operacionais Padrão (Pops), 2023**. Disponível em: <https://enfermagemndi.paginas.ufsc.br/files/2020/09/Pops.pdf>. Acesso em 10/09/2024;

SANTA CATARINA. Universidade Federal de Santa Catarina. Centro de Ciências da Educação. Núcleo de Desenvolvimento Infantil. **POP nº15 - Verificação de Sinais Vitais, 2018**. Disponível em: <https://enfermagemndi.paginas.ufsc.br/files/2020/09/VERIFICA%C3%87%C3%83O-DE-SINAIS-VITAIS.pdf>. Acesso em 03/07/2024;

SÃO PAULO. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Nutrologia. **Manual de Avaliação Nutricional da Criança e do Adolescente. 2ª edição – Atualizada/2021**. Disponível em:

https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/22962e-ManAval_Nutricional_-_2Ed_Atualizada_SITE.pdf. Acesso em 07/10/2024;

SÃO PAULO. Campinas. Faculdade de Ciências Médicas. **Reflexos Primitivos**. Disponível em: <https://www.fcm.unicamp.br/fcm/neuropediatria-conteudo-didatico/exame-neurologico/reflexos-primitivos>. Acesso em 12/06/2024;

SÃO PAULO. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Pediatria do Comportamento e Desenvolvimento. **Caderneta de Saúde da Criança - Instrumento e Promoção do Desenvolvimento: como avaliar e intervir em crianças**. Disponível em: https://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/20493c-GPA_-_Caderneta_de_Saude_da_Crianca.pdf. Acesso em 05/10/2024;

SÃO PAULO. Sociedade Brasileira de Pediatria. Caderneta de Saúde da Criança. **Desenvolvimento Puberal de Tanner**. Disponível em: <https://www.sbp.com.br/departamentos/endocrinologia/desenvolvimento-puberal-de-tanner/>. Acesso em 17/06/2024;

VASCONCELOS, Josilene de Melo Buriti et al. **Exame Físico Na Criança: Um Guia Para O Enfermeiro**. R. Bras. Enferm., Brasília, v. 52, n.4, p. 529-538, out/dez. Brasília - DF: 1999.

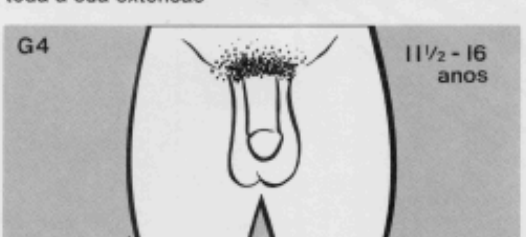
Elaborado por:	Revisado por:	Aprovado por:
2025 Fernanda Cristina Spiller	2025 Fatima Mucha Indianara da Silva Vivianne Samara Conzatti Willian Waldelino Custódio da Silva	2025 Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI): Processo nº 25.0.088137-1
Wiki da Prefeitura: https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/Área:_Saúde

Anexo 01. Estadiamento de Tanner - Masculino

Desenvolvimento Puberal Masculino

Critérios de Tanner

Genitália	Pêlos pubianos
G1  Pré-adolescência (infantil)	P1  Fase pré-adolescência (não há pelagem)
G2  9 1/2 - 13 1/2 anos Aumento do escroto e dos testículos, sem aumento do pênis	P2  11 - 15 1/2 anos Presença de pêlos longos, macios, ligeiramente pigmentados, na base do pênis
G3  10 1/2 - 15 anos Ocorre também aumento do pênis, inicialmente em toda a sua extensão	P3  11 3/4 - 16 anos Pêlos mais escuros, ásperos, sobre o púbis
G4  11 1/2 - 16 anos Aumento do diâmetro do pênis e da glândula, crescimento dos testículos e escroto, cuja pele escurece	P4  12 - 16 1/2 anos Pelagem do tipo adulto, mas a área coberta é consideravelmente menor que no adulto
G5  12 1/2 - 17 anos Tipo adulto	P5  13 - 17 anos Tipo adulto, estendendo-se até a face interna das coxas

Na avaliação dos adolescentes, durante a puberdade, deve-se observar o aparecimento de pelos e o crescimento da genitália. A puberdade pode se iniciar dos 9 aos 14 anos e alguns aspectos devem ser observados, tais como:

- 1- A primeira manifestação da puberdade no sexo masculino é o aumento do volume testicular, em média aos 10 anos e 9 meses. O saco escrotal torna-se mais baixo e alongado, mais solto e enrugado e mede cerca de 3cc.
- 2- O crescimento peniano começa, em geral, um ano após o crescimento dos testículos.
- 3- O início da puberdade antes dos 09 anos também pode ser motivo de preocupação, pode-se tratar de uma puberdade precoce e, portanto, deve-se sempre referir o adolescente ao serviço de referência para melhor ser avaliado.
- 4- Desenvolvimento de genitália. Recomenda-se, que o profissional de saúde responsável pela avaliação do adolescente, quando não munido do orquidômetro, proceda da seguinte forma:
 - a) faça a avaliação do peso e altura do adolescente.
 - b) mostre a prancha de estágios de Tanner ao adolescente e solicite ao mesmo que indique em que momento do seu desenvolvimento ele se encontra a partir do que foi visto.
 - c) faça a relação entre o peso e a altura e o estágio referido pelo adolescente.
 - d) o profissional poderá ainda, durante a entrevista, investigar possíveis alterações nas queixas e relatos do adolescente. Além de ser um método de avaliação seguro, permite ao adolescente a percepção de si e o autoconhecimento. Além de ser um método não invasivo.

* caso o profissional utilize o orquidômetro de Prader ver: www.saude.gov.br
- 5- Observar que primeiro o pênis cresce em tamanho e depois em diâmetro. Quando o adolescente termina sua fase de crescimento, seu pênis atinge em média 12 cm e 15 cm quando ereto, podendo variar mais ou menos de 2 a 3 cm.
- 6- A idade da primeira ejaculação, conhecida como semenarca ou espermarca, ocorre em média aos 12 anos e 8 meses. Geralmente, acontece também a polução noturna, ou seja, a ejaculação involuntária de sêmen quando o adolescente está dormindo. Trata-se de evento fisiológico normal, que deve ser orientado e tranquilizado pelo profissional de saúde.
- 7- Observar que pode aparecer o crescimento do broto mamário no menino, ginecomastia puberal (aumento do tecido mamário) verifica-se em grande parte dos adolescentes masculinos. É frequentemente bilateral, tem consistência firme e móvel e, às vezes, muito dolorosa.
- 8- Pode-se classificar a ginecomastia, de acordo com o diâmetro, em: grau I, de 1 a 2 cm; grau II, de 2 a 4 cm, e grau III, de 5 cm em diante. A conduta é tranquilizar o adolescente e observar por até três anos, onde cerca de 85% regridem espontaneamente. Se trazer grande sofrimento ao adolescente, encaminhar ao profissional de saúde para conduzir e avaliar a necessidade de uso de medicamento e/ou encaminhar ao cirurgião.
- 9- A ginecomastia de causa patológica (por drogas, endocrinopatias, tumores ou doenças crônicas), embora rara, deve ser pensado se ocorrer antes ou ao término da maturação sexual, devendo ser cuidadosamente avaliada e encaminhada para o serviço de referência.
- 10- É importante observar que deve-se considerar retardo puberal em meninos, a ausência de qualquer característica sexual secundária a partir dos 14 anos de idade.

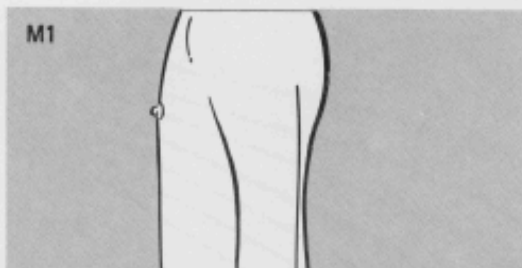
Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2025.



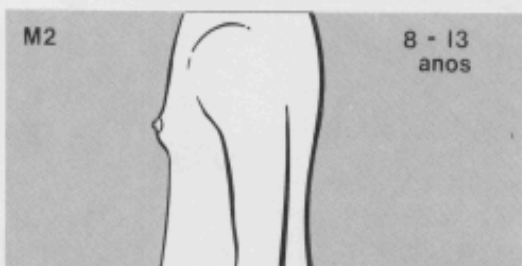
Anexo 02. Estadiamento de Tanner - Feminino

Desenvolvimento Puberal Feminino Critérios de Tanner

Mamas



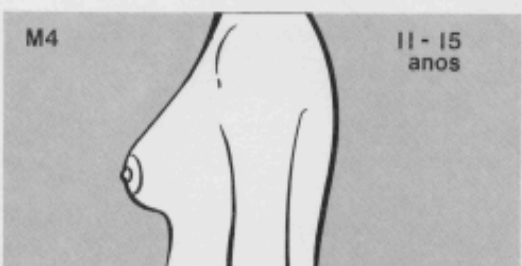
M1
Fase pré-adolescência (elevação das papilas)



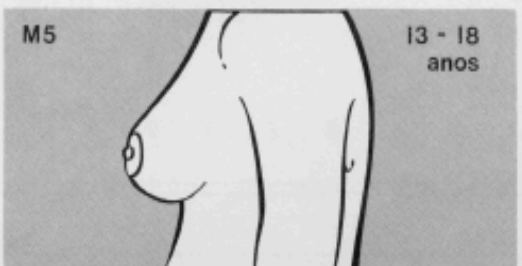
M2
Mamas em fase de botão (elevação da mama e aréola como pequeno montículo)
8 - 13 anos



M3
Maior aumento da mama, sem separação dos contornos
10 - 14 anos

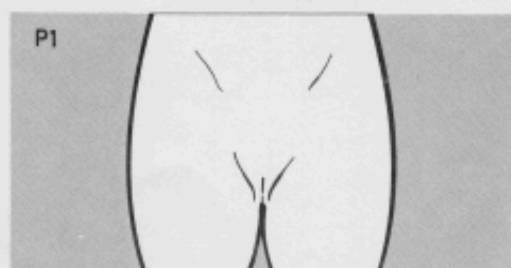


M4
Projeção da aréola e das papilas para formar montículo secundário por cima da mama
11 - 15 anos

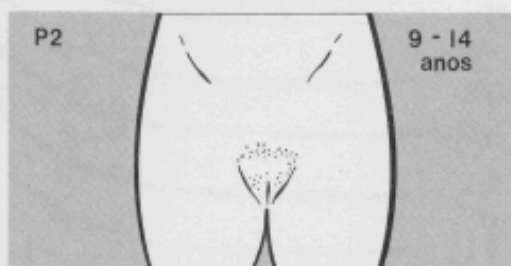


M5
Fase adulta, com saliência somente das papilas
13 - 18 anos

Pêlos pubianos



P1
Fase pré-adolescência (não há pelagem)



P2
Presença de pêlos longos, macios, ligeiramente pigmentados, ao longo dos grandes lábios
9 - 14 anos



P3
Pêlos mais escuros, ásperos, sobre o púbis
10 - 14 1/2 anos



P4
Pelagem do tipo adulto, mas a área coberta é consideravelmente menor que no adulto
11 - 15 anos



P5
Pelagem tipo adulto, cobrindo todo o púbis e a virilha
12 - 16 1/2 anos

11 a 5m



M
E
N
A
R
C
A

15 a 6m



Na avaliação das adolescentes, durante a puberdade deve-se observar o aparecimento de mamas e pelos. A puberdade pode se iniciar dos 8 aos 13 anos e alguns aspectos devem ser considerados, tais como:

- 1- O broto mamário é o primeiro sinal puberal na menina, é chamado de telarca e pode apresentar-se unilateralmente sem significado patológico. Observar a adolescente, tranquilizá-la e reavaliar após seis meses, quando a outra mama já terá aparecido e os primeiros pelos pubianos também.
- 2- Caso a puberdade se inicie com o aparecimento de pelos pubianos e não com o broto mamário, deve-se encaminhar ao profissional de saúde, pois pode se tratar de uma puberdade de origem periférica e não central pelo estímulo hipofisário - gonadal podendo se tratar de uma causa patológica, devendo ser melhor investigada.
- 3- O início da puberdade antes dos 8 anos também pode ser motivo de preocupação e, portanto, deve-se sempre referir a adolescente ao profissional de saúde para que ele avalie junto ao endocrinologista se é uma puberdade precoce.
- 4- É frequente ocorrer um **corrimento vaginal claro nos 6 aos 12 meses que antecedem a primeira menstruação ou menarca**, fato marcante da puberdade feminina. Esclarecer a adolescente que é natural, pois trata-se do crescimento do tecido endometrial uterino e que deve-se apenas cuidar mais da higiene corporal.
- 5- Atentar que a idade média da menarca em nosso meio é de 12 anos e 4 meses, mas pode ocorrer entre 9 e 16 anos, observar comportamento do evento na família e acompanhar o processo de cada adolescente.
- 6- Os primeiros ciclos menstruais são geralmente anovulatórios e irregulares, podendo essa irregularidade permanecer por até 2 ou 3 anos.
- 7- O ciclo menstrual normal tem um intervalo que varia de 21 a 36 dias e uma duração entre 3 e 7 dias.
- 8- As adolescentes podem ainda crescer em média 4 a 6 cm nos 2 ou 3 anos após a menarca.
- 9- **É importante observar que se deve considerar retardo puberal em meninas a ausência de qualquer característica sexual secundária a partir dos 13 anos de idade.**

Fonte: Sociedade Brasileira de Pediatria, 2025.

